



Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une affection oculaire fréquente qui touche la **macula**, la partie centrale de la rétine responsable de la vision centrale. Elle peut rendre la lecture, la reconnaissance des visages ou la conduite plus difficiles, en particulier chez les personnes âgées.

Types de DMLA

- DMLA sèche (la plus courante – ~90 % des cas) :
Causede par un amincissement progressif de la macula au fil du temps.
- DMLA humide (moins fréquente mais plus grave) :
Due à la croissance anormale de vaisseaux sanguins sous la rétine, qui peuvent fuir et provoquer une perte de vision rapide.

Symptômes

- Vision centrale floue ou imprécise
- Lignes droites apparaissant ondulées
- Difficulté à lire ou à reconnaître les visages
- Tache noire ou vide au centre du champ de vision

La vision périphérique (latérale) est généralement **préservée**.

Facteurs de risque

- Âge supérieur à 50 ans
- Tabagisme
- Antécédents familiaux de DMLA
- Hypertension artérielle ou maladies cardiovasculaires
- Alimentation pauvre en légumes verts ou antioxydants
- Exposition excessive au soleil

Diagnostic

La DMLA est diagnostiquée lors d'un examen complet de la vue, comprenant souvent :

- Examen avec dilatation pour observer la macula



- OCT (tomographie par cohérence optique) pour visualiser en détail la rétine
- Grille d'Amsler pour détecter les déformations visuelles
- Angiographie à la fluorescéine (surtout pour la DMLA humide)

Options de traitement

Il n'existe pas de remède contre la DMLA, mais certains traitements peuvent ralentir son évolution et préserver la vision.

DMLA sèche :

- Alimentation saine (légumes verts, oméga-3, antioxydants)
- Suppléments de type AREDS2 (si recommandés)
- Arrêt du tabac, protection des yeux contre les UV

DMLA humide :

- Injections anti-VEGF (par ex. Lucentis, Eylea, Avastin)
 - Administrées directement dans l'œil pour bloquer la croissance des vaisseaux anormaux
 - Souvent réalisées tous les mois ou tous les 1 à 3 mois
- Parfois, traitement au laser

Vivre avec la DMLA

- Suivi régulier et imagerie répétée
- Utilisation de lampes à contraste élevé et de loupes
- Surveillance de la vision à domicile avec une grille d'Amsler
- Demander des conseils sur les services de réadaptation visuelle

Foire aux questions (FAQ)

Q : La DMLA peut-elle rendre aveugle ?

R : Elle peut entraîner une perte importante de la vision centrale, surtout en cas de DMLA humide, mais elle ne provoque presque jamais une cécité totale.

Q : Les injections sont-elles douloureuses ?

R : La plupart des patients ressentent seulement une légère pression — l'œil est anesthésié au préalable.



Q : Les lunettes peuvent-elles corriger la DMLA ?

R : Les lunettes peuvent améliorer la vision générale, mais elles ne traitent pas la DMLA elle-même.